UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

CARDIOLOGIE- Sujet 4

FIBRILLATION ATRIALE

Sans patient simulé

Sans geste clinique

Nom du rédacteur : DACQUAY Robin **Date de rédaction : 05/12/2023**

Relecture intra-ou transdisciplinaire :

Situation de départ N° 185 – Réalisation et interprétation d'un électrocardiogramme

Domaine de compétence principal : Stratégie diagnostique

Domaine de compétence secondaire : Stratégie de prise en charge

Attendus d'apprentissage de la situation abordée :

1- Interpréter de manière structurée un électrocardiogramme

2- Identifier les critères de qualité et de bonne réalisation d'un ECG

Patient simulé nécessaire à la station : NON

Matériel nécessaire à la station

- Mannequin : NON
- Brancard : NON
- Document annexe : ECG

Vous ne répondrez aux questions suivantes que si l'évalué (étudiant-médecin) vous les pose. Si les questions de l'étudiant-médecin ne sont pas listées ci-dessous, répondre « je ne sais pas ».

Questions éventuellement posées par l'étudiant - médecin	**Réponses à donner par <u>l'examinateur</u>**
Est-ce que le patient a une insuffisance rénale ?	Non, le patient n'a pas d'insuffisance rénale.

Instructions à l'étudiant

Vous êtes interne en cardiologie à l'hôpital Pasteur à Nice.

Vous recevez en consultation M.F, un homme de 78 ans, pour des sensations de palpitations cardiaques intermittentes associées à une dyspnée d'effort, d'apparition progressive depuis quelques semaines.

Ce patient a pour antécédent notable une hyperthyroïdie connue et suivie, et une HTA sous hydrochlorothiazide.

Ces palpitations sont hémodynamiquement bien tolérées par le patient, et il n'y a aucun autre signe fonctionnel associé.

Vous avez devant vous l'ECG de M.F.

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Analyser/ Interpréter l'ECG du patient, et donner votre principale hypothèse diagnostique concernant cet ECG.

2. Enoncer la prise en charge thérapeutique que vous proposeriez à M.F, ainsi que le bilan systématique de première intention.

AUCUN PATIENT PRÉSENT POUR LA STATION.

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Pondération (entre 1 et 5)
ANALYSE/INTERPRÉTATION ECG	
Enonce que c'est un ECG 12 derivations	
Enonce l'extrasystole ventriculaire	
Analyse la fréquence : tachycardie irrégulière	
Analyse le rythme : rythme non sinusal, absence d'onde P	
Analyse l'axe : QRS positif en D1 et négatif en aVF : axe hypergauche	
Analyse la conduction : pas de trouble de conduction, QRS fins	
Recherche une hypertrophie ventriculaire gauche par l'indice de Sokolow : absence d'HVG.	
Analyse de la repolarisation : pas de trouble de repolaration, pas de sus ni sous décalage du segment ST.	
Emet l'hypothèse diagnostique d'un accès de fibrillation atriale (tachycardie irrégulière à QRS fins)	
PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE	
Propose une stratégie thérapeutique par cardioversion, précédée par un traitement anticoagulant efficace pendant au moins 3 semaines.	
Propose un traitement par AOD pour au moins 3 semaines	
Propose un traitement de contrôle de la fréquence en attendant la cardioversion *(bêtabloquant, inhibiteurs calciques bradycardisants, digoxine)* *OK si l'étudiant propose un des traitements*	
Enonce le bilan biologique systématique devant une FA : NFS-plaquette, ionogramme, créatininémie, TSH, bilan hépatique, bilan d'hémostase *(ok si 4/6)*	
Enonce la réalisation systématique d'une radiographie thoracique de face (*cardiomégalie, dilatation de l'OG, anomalie du parenchyme pulmonaire*)	
Enonce la réalisation systématique d'une ETT (*pour évaluer la fonction cardiaque, l'état des valves, HVG, FEVG, cardiopathie)*	

COMPETENCES GENERIQUES	
Aptitude à faire la synthèse des données.	
Aptitude à planifier les soins.	
Aptitude à planifier une prise en charge.	
	Cocher si fait

Fiche de correction avec le barème

	Pondération (entre 1 et 5)
ANALYSE/INTERPRÉTATION ECG	
Vérifie que l'ECG est de bonne qualité et interprétable	1
Analyse la fréquence : tachycardie irrégulière	1
Analyse le rythme : rythme non sinusal, absence d'onde P	1
Analyse axe : QRS positif en D1 et négatif en aVF : axe hypergauche	1
Analyse la conduction : pas de trouble de conduction, QRS fins	1
Recherche une hypertrophie ventriculaire gauche par l'indice de Sokolow : absence d'HVG.	1
Analyse de la repolarisation : pas de trouble de repolaration, pas de sus ni sous décalage du segment ST.	1
Emet l'hypothèse diagnostique d'un accès de fibrillation atriale (tachycardie irrégulière à QRS fins)	1
PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE	
Propose une stratégie thérapeutique par cardioversion, précédée par un traitement anticoagulant efficace pendant au moins 3 semaines.	1
Propose un traitement par AOD pour au moins 3 semaines	1
Propose un traitement de contrôle de la fréquence en attendant la cardioversion *(bêtabloquant, inhibiteurs calciques bradycardisants, digoxine)* *OK si l'étudiant propose un des traitements*	1
Enonce le bilan biologique systématique devant une FA : NFS-plaquette, ionogramme, créatininémie, TSH, bilan hépatique, bilan d'hémostase *(ok si 4/6)*	1

Enonce la réalisation systématique d'une radiographie thoracique de face (*cardiomégalie, dilatation de l'OG, anomalie du parenchyme pulmonaire*)	1
Enonce la réalisation systématique d'une ETT (*pour évaluer la fonction cardiaque, l'état des valves, HVG, FEVG, cardiopathie)*	1
Propose de réévaluer le patient à 3 semaines d'anticoagulation pour voir si une cardioversion (*par CEE ou médicamenteuse*) est nécéssaire	1
COMPETENCES GENERIQUES	
Aptitude à faire la synthèse des données.	1
Aptitude à planifier les soins.	1
Aptitude à planifier une prise en charge.	1